REIN · SURRÉNALE · RS-01

# Masse kystique rénale · Bosniak 2019

**Bosniak v2019**
scanner et IRM · protocole masse rénale

**Prérequis :** scanner ou IRM avec **protocole « masse rénale »** (sans injection + phase néphrographique ± tardive). Système de prédiction de malignité, non de prise en charge. La taille et les calcifications n'entrent plus dans la classification. Définitions : paroi ou cloison **fine ≤ 2 mm**, **discrètement épaissie 3 mm**, **épaisse ≥ 4 mm** ; cloisons **peu nombreuses 1–3**, **nombreuses ≥ 4**.

## CLASSIFICATION BOSNIAK V2019

| CLASSE | SCANNER | IRM | MALIGNITÉ | CONDUITE |
|---|---|---|---|---|
| I | Bien limité, paroi fine et lisse (≤ 2 mm) rehaussée, **liquide simple** (−9 à 20 UH ; signal liquidien en IRM), ni cloison ni calcification | | ≈ 0 % | Aucune |
| II | • Kystique avec 1–3 cloisons fines rehaussées<br>• Homogène **≥ 70 UH** sans injection<br>• Homogène non rehaussé > 20 UH (protocole masse rénale)<br>• Homogène −9 à 20 UH sans injection<br>• Homogène 21–30 UH en phase portale<br>• Homogène hypodense trop petit pour être caractérisé | • Cloisons fines peu nombreuses<br>• Homogène **très intense en T2** (sans injection)<br>• Homogène **très intense en T1** (≈ 2,5 × le parenchyme) sans injection | ≈ 0 % | Aucune |
| IIF | Paroi lisse **discrètement épaissie (3 mm)** rehaussée, ou cloison(s) lisse(s) discrètement épaissie(s), ou **≥ 4 cloisons** fines lisses rehaussées. IRM : aussi kyste hétérogène hyperintense T1 en saturation de graisse | | ≈ 5–10 % | Contrôle à 6 et 12 mois puis annuel pendant 5 ans |
| III | Paroi ou cloison(s) **épaisse(s) ≥ 4 mm** ou **irrégulière(s)** (protrusion à bords obtus ≤ 3 mm) rehaussée(s) | | ≈ 50 % | Surveillance active ou chirurgie / ablation |
| IV | **Nodule rehaussé** : protrusion à bords obtus ≥ 4 mm, ou protrusion à **bords aigus** de toute taille | | ≈ 90 % | Chirurgie ou ablation |

Rehaussement : en scanner, ≥ 20 UH entre sans et avec injection ; en IRM, rehaussement visible ou en soustraction. Une masse avec > 25 % de composante tissulaire n'est pas un kyste : c'est une masse solide.

## PIÈGES

### Techniques

- Pseudo-rehaussement en scanner (petits kystes, phase néphrographique, scanner double énergie utile)
- Coupes trop épaisses : paroi mal mesurée
- L'IRM peut sur-classer (cloisons plus visibles) : interpréter avec prudence

### Lésionnels

- Kyste hémorragique ou infecté : ne pas classer en phase aiguë, contrôler
- Calcifications épaisses masquant un rehaussement : compléter par IRM ou CEUS
- CEUS : très sensible au rehaussement des cloisons, tendance à sur-classer

## COMPTE RENDU

**Taille et siège**
rein, pôle, exophytique ou non

**Paroi et cloisons**
épaisseur en mm, nombre, régularité, rehaussement

**Nodule**
bords obtus ou aigus, taille de la protrusion

**Classe et conduite**
Bosniak v2019 et proposition de suivi

# Masse kystique rénale · Bosniak 2019 (suite)



## ATLAS VISUEL

### Classes de Bosniak v2019 (après injection)



| I | II | IIF | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| paroi fine ≤ 2 mm, liquide | 1–3 cloisons fines | ≥ 4 cloisons ou paroi 3 mm | paroi ou cloison ≥ 4 mm, irrégulière | nodule rehaussé |

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Bosniak v2019**
Radiopaedia · définitions
radiopaedia.org/articles/bosniak-classification-

**Bosniak : illustrations**
Radiopaedia · schémas des classes
radiopaedia.org/cases/bosniak-classification-of-

**Kyste Bosniak IV (cas)**
Radiopaedia · nodule rehaussé
radiopaedia.org/cases/renal-cyst-bosniak-class-i

**Sources :** Silverman et al., Radiology 2019 – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019182646 · Bosniak v2019 pitfalls (Abdom Radiol) – link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00261-020-02906-8.pdf · Bosniak 2019 – CEUS (Med Ultrason) – medultrason.ro/medultrason/index.php/medultrason/article/dow...